

Etablissement

Médecin responsable

PROTOCOLE MÉDICAL DE SOINS INFIRMIERS — ARTICLE R.4311-6 CSP

Diarrhée aiguë simple – Racécadotril

Traitement adjuvant court, toujours associé à la réhydratation et hors diarrhée invasive, grave ou post-antibiotique.

Indications

- Au moins 3 selles liquides ou très molles en 24 h.
- État général conservé, sans déshydratation sévère.
- Absence de sang/pus, fièvre élevée, abdomen aigu ou diarrhée post-antibiotique.
- Enfant ≥ 3 mois : toujours avec soluté de réhydratation orale (SRO).

Vérifications préalables

- Température, douleur, vomissements, sang/glaires et nombre de selles.
- Poids, hydratation, diurèse, TA et conscience.
- Antibiotique récent, laxatif, fécalome, grossesse/allaitement.
- Insuffisance rénale/hépatique ; IEC/ARA2 ; antécédent d'angio-œdème.

Recommandations / IMPORTANT

- Pas de racécadotril si sang/pus avec fièvre, diarrhée post-antibiotique ou vomissements incoercibles.
- Éviter pendant grossesse/allaitement et en insuffisance rénale/hépatique sans avis médical.
- Arrêter et appeler si œdème du visage/langue, dyspnée ou éruption sévère.
- Le traitement ne remplace jamais la réhydratation.

Intervention IDE

- Adulte ≥ 18 ans : 100 mg immédiatement, puis 100 mg 3 fois/j avant les repas ; maximum total J1 = 3 gélules.
- Enfant < 9 kg : 1 sachet de 10 mg/prise ; 9– < 13 kg : 2 sachets de 10 mg/prise, 3 fois/j.
- Enfant 13–27 kg : 1 sachet de 30 mg/prise ; > 27 kg : 2 sachets de 30 mg/prise, 3 fois/j, avec SRO.
- Arrêt après 2 selles formées consécutives ; durée maximale 7 jours.

Surveillance et traçabilité

- Tracer selles, hydratation, température, poids, dose, heure et effet.
- Surveiller apports, diurèse, TA, conscience, douleur et peau.
- Réévaluer dans les 24 h ; peser le nourrisson/enfant si possible.
- Avis médical si absence d'amélioration ou fragilité.

Alerte immédiate

- Appel médecin : persistance > 24 h, fièvre, douleurs, rash, déshydratation ou traitement par IEC/ARA2.
- Appel 15 : collapsus, confusion, déshydratation sévère, abdomen aigu ou rectorragies abondantes.
- Urgence si angio-œdème ou détresse respiratoire.

Mention de sécurité

Chez l'enfant, le SRO est le traitement essentiel ; poursuivre l'alimentation adaptée. Le racécadotril est seulement symptomatique et expose rarement à angio-œdème ou réaction cutanée grave. Administration ou acte tracé dans le dossier de soins.

Fait à :

Le : / /

Signature et cachet du médecin :